

אפילפסיה ופרכוסים



הגדרה

- פרכוס - שינויים זמניים בהתנהגות, או בהכרה, הנגרמים מפעילות חשמלית לא תקינה של המוח
- Aura - תחושה מקדימה לפרכוס (ריח שרוף, טעם מתכתי, הזיות...)
- אפילפסיה - הפרעה המאופיינת בלפחות שני התקפי פרכוסים במהלך החיים, שאינם נגרמים במכוון או שלא נמצא להם גורם (פרכוס ראשוני)



ביטויי הפרכוס

- במהלך הפרכוס יופיעו אחד או יותר מהסימנים הקליניים הבאים:
- סטיית מבט, בהייה באוויר או חוסר מיקוד מבט
- חוסר הכרה
- שינוי התנהגותי קיצוני
- תנועת שרירים בלתי מבוקרת ובלתי רצונית
- עלול לגרום לחבלות משניות
- אובדן טונוס שרירים
- ייתכן וילווה באובדן שליטה על סוגרים
- טונוס שרירים מוגבר
- ייתכן וילווה בנעילת לסתות, נשיכת לשון ודימומים מחלל הפה
- קוצר נשימה
- ייתכן וילווה ביציאת "קצף מהפה"

גורמים לפרכוס

- עלפון
- זיהום
- תרופות וסמים
- תסמונת גמילה מאלכוהול
- רעלת הריון
- הפרעות מטבוליות
- הפרעות אלקטרוליטריות
- הדיופתי
- תורשה
- היפוקסיה
- פגיעת ראש
- שבץ מוחי - Stroke
- גידולים
- סוכרת (היפוגליקמיה)
- חום



מצב פוסט-איקטלי

- לאחר הפרכוס קיים מצב של התאוששות גופנית
- מצב זה מכונה - התקופה הפוסטאיקטלית (Postictal)

- מאפייני השלב

המטופל איננו מפרכס פרכוס פעיל

- שינויים במצב ההכרה או הכרה מלאה מלווה בבלבול וחוסר התמצאות בסביבה
- לעיתים דווקא בשלב זה, מיד עם סוף הפרכוס - ישנו אובדן שליטה על הסוגרים
- אגיטציה, תוקפנות וחוסר שיתוף פעולה או עייפות וישנוניות מוגברים
- לרוב השלב הפוסטאיקטלי דומה בין פרכוס לפרכוס באותו המטופל
- לרוב חולף תוך מספר דקות, אך יכול לחלוף גם לאחר מספר שעות
- כלל התופעות הנזירותולוגיות הינן זמניות וחולפות ומשתפרות בהדרגה
- בשלב זה המטופל נמצא בסכנה הגבוהה ביותר לפרכוס חוזר

• Partial Onset/Seizure - התקף "שקט", ממוקד
• בד"כ כתוצאה מפגיעה ממוקדת בחלק מהמוח

• Generalized Onset/Seizure - התקף "רועש", כללי
• לרוב עקב פגיעה בשתי המיספרות

• לכל פרכוס יש סיכוי להתפתח לפרכוס כללי
• על כן יש לעצור כל פרכוס בהקדם

Partial Seizure

Simple Partial Seizure •

- פרכוס ללא פגיעה בהכרה
- מעורבות של הקורטקס המוטורי / סנסורי
- ייתכנו חסכים נוירולוגיים חולפים

Complex Partial Seizure •

- כל פרכוס חלקי פשוט עם אובדן הכרה לאחריו
- או פרכוס המתבטא באובדן הכרה בלבד

Generalized Seizure

- ההתקף השקט - Petit Mal
- לעיתים נקרא Absence Seizure
- מאופיין בתחושה מקדימה - Aura
- לעיתים יופיע כפרקוס ממוקד / בחלק מהגוף
- במהלך הפרקוס - ירידה במצב ההכרה, החולה חווה ניתוק רגעי מהסביבה
- ייתכנו מצבים טונים, קלוניים או אטוניים רגעיים
- נפוץ בעיקר בילדים בגילאי 4-12
- קושי באבחנה עקב משך קצר (לרוב כ-15 שניות)
- מצב פוסט-איקטלי קצר יחסית

Generalized Seizure

• Grand Mal לעיתים גם מכונה Tonic Clonic

- רוב המקרים בהם אנו נתקלים
- בד"כ אין תחושה מקדימה או שהתחושה נשכחת

מאפיינים:

- אובדן הכרה פתאומי
- פרכוס כללי עם פאזות קלוניות וטוניות

סכנות:

- אפניאה
- אספירציה
- נשיכת לשון ואספירציה
- היפוקסיה מוחית

- מצב פוסט-איקטלי ארוך

Status Epilepticus

• פרכוס מתמשך או רצף של פרכוסים - מכל סוג

הגדרה משתנה בספרות

- לאחרונה מקובל 5-15 דקות (איגוד רופאי האפליפסיה 2019)
- או פרכוס ממושך שלא מגיב לטיפול תרופתי (פרכוס רפרקטורי)
- או התרחשות של מספר אירועי Grand Mal (שניים לפחות)
ללא חזרה להכרה בין פרכוס לפרכוס

• מצב מסכן חיים - היפוקסיה מוחית ממושכת

אאורה

• האם הופיעו תחושות מקדימות או התנהגויות מקדימות לפרכוס?

אופי הפרכוס

• דומה לאירועים קודמים?

אפילפסיה ברקע?

• או במשפחה

• שימוש בתרופות (שינוי מינון/תרופה)

מצב פוסט-אקטלי

• כמה זמן עד להתאוששות?

כמה זמן התרחש האירוע?

• תדירות - האם היה אירוע בודד או מספר אירועים?

• מתי היה האירוע האחרון (לפני הנוכחי שבגיננו הוזמנו)?

פרוטוקול פרכוסים

מעודכן לאפריל 2024



בזמן פרכוס

- ABC
- ריפוד ראש החולה
- חמצן
- הטייה הצידה
- אין להחזיק בכח ראש, ידיים ורגלים
- במידת הניתן – וריד ומוניטור
- בדיקת סוכר ואישונים
- תרופות: דורמיקום
- חיפוש אחר הגורם

לאחר פרכוס

- ABC
- אנמנזה בדגש על הבנת המנגנון
- פגיעות משניות
- סיכוי לפרכוס חוזר
- וריד וניטור
- טכיקרדיה פתאומית תהיה הסימן הנפוץ להופעת פרכוס חוזר
- בדיקת סוכר ואישונים (סטיית מבט)
- חיפוש אחר הגורם

פרכוס או לאחר פרכוס

חמצן

- יש לספק חמצן לשמירה על ערכי סטורציה בטווח של 94-99%

היפוגליקמיה

- הפרכוס דורש משאבי אנרגיה אדירים מהגוף, במידה ולאחר הפרכוס נמדדה רמת סוכר נמוכה יש לתת גלוקוז בהתאם לפרוטוקול

דורמיקום

- ניתן לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות
- יש לעצור את הפרכוס ללא תלות בלחצי הדם, אך להפעיל שיקול דעת

ניטור

- מוניטור, סטורציה ולחץ דם עלולים להניב תוצאות לא אמינות בזמן פרכוס של הגפיים

שאלה למחשבה

איפה נעדיף לפתוח
וריד למטופל
מפרכס/לאחר פרכוס?

דורמיקום

- שם גנרי: MILDOLAM / MIDAZOLAM
- מנגנון פעולה: תרופה ממשפחת הבנזודיאזפינים, המשמשת להרגעה, שינה, והפחתת חרדה והזיות.
- אמפולה: 5 מ"ג ב 1 מ"ל.
- התוויות לשימוש: פרכוסים, חולה משתולל, סדציה.
- התוויות נגד: לחץ דם נמוך מ 90 סיסטולי, גלאוקומה.
- תחילת השפעה: IV תוך דק' בודדות.
- IN תוך כעשר דק'.



שאלה לדין

איפה נמצאת התרופה
באטן? (מיקום בתיק
תרופות)

המטופל מפרנס או במצב שלאחר פרוכוס

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- ◀ השכב את המטופל על צידו, ככל האפשר ¹
- ◀ שקול מתן חמצן ²
- ◀ התקן עירוי תוך־ורידי או תוך־לשדי

כן / לא האם חל שיפור במצב המטופל?

תן דורמיקום ³ ב־I.V / I.M / I.N

- ◀ חבר מוניטור למטופל
- ◀ בדוק מדדים חיוניים
- ◀ בדוק את רמת הסוכר בדם ⁴

כן / לא האם יש חשד לאקלמפסיה?

- ◀ המשך ניטור וטיפול בזמן כינוי דחוף לבית החולים הקרוב
- ◀ בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- ◀ שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

עבור לפרוטוקול
רעלת היריון
(פרה־אקלמפסיה / אקלמפסיה)

1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. שימוש בריפוד להגנה ולמניעת חבלת ראש אצל המטופל. השכבת נשים בהיריון על צד שמאל.

2 חמצן
מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה בטווח של 94%-99%.

3 דורמיקום
+ מינון למתן ב־I.V – 5 mg.
+ מינון למתן ב־I.M – 10 mg.
+ מינון למתן ב־I.N – 10 mg.
+ אם הפרנס נמשך אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
+ לאחר מתן דורמיקום יש לעקוב אחר לחץ הדם. במקרה של ירידה בלחץ הדם יש לתת עירוי נוזלים.

4 היפוגליקמיה
+ אם ערכי הסוכר בדם נמוכים מ־60 mg%, יש לתת גלוקוז ב־I.V (25 gr של תמיסת גלוקוז בריכוז 25%).
+ יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
+ אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

- + רובם המכריע של הפרכוסים יסתיימו עצמונית בתוך 5 דקות. קיים סיכוי של 6% להתקף חוזר בתוך 24 שעות.
- + סטטוס אפילפטיקוס הוא פרכוס הנמשך למעלה מ־5 דקות ברציפות או כמה פרכוסים עוקבים מבלי שהמטופל חוזר להכרה מלאה ביניהם.

סיבוכים

- + שיעור התמותה כתוצאה מפרכוס מתמשך או מפרכוסים חוזרים הוא כ־15%.
- + סוגי הסיבוכים האפשריים (בשיעור של עד 30%) – היפרתרמיה, בצקת ריאות, הפרעות קצב, חסרים נוירולוגיים ממוקדים, אנצפלופתיה.
- + אקלמפסיה – אפשרית משבוע 20 להיריון עד חודשיים לאחר הלידה.

דגשים לתשאול המטופל וסביבתו

- + יש לברר אם המטופל סובל ממחלות רקע, כגון אפילפסיה, סוכרת, היריון, מחלת חום שאירעה לאחרונה, מחלות לב, גידולים סרטניים.
- + יש לברר אם המטופל מדווח על הופעת "Aura" טרם ההתקף; האם הפרכוס מוקדי (פוקלי); האם היה אובדן שליטה על הסוגרים; האם הפרכוס כלל תנועות טוניות־קלוניות; האם נגרמה חבלה כתוצאה מהפרכוס; האם המטופל נוטל טיפול תרופתי קבוע.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית

- + יש להעריך את מצב ההכרה של המטופל; האם יש סטיית מבט קבועה היכולה להעיד על פרכוס מתמשך; האם נתיב אוויר שלו פתוח; האם נצפים חסרים נוירולוגיים; האם יש סימני חבלה חיצוניים.
- + אין להכניס אצבעות לפיו של מטופל מפרכס או במצב שלאחר פרכוס בניסיון לפתוח נתיב אוויר.